TEMA 3 · Proceso enfermero. Derechos y deberes de los usuarios (Ley 3/2009) y Ley de Transparencia de Murcia

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: El proceso de atención de enfermería (PAE) · Bloque B: Ley 3/2009 de derechos y deberes y Ley 12/2014 de Transparencia

Siglas y leyes de este tema

Sigla o norma	Nombre completo	De qué va
PAE	Proceso de Atención de Enfermería (o proceso enfermero)	El método de trabajo de la enfermera, en 5 fases
NANDA-I	NANDA Internacional (antes North American Nursing Diagnosis Association)	Clasificación de **diagnósticos** enfermeros
NOC	Nursing Outcomes Classification	Clasificación de **resultados** (objetivos)
NIC	Nursing Interventions Classification	Clasificación de **intervenciones**
PES	Problema, Etiología, Signos y síntomas	Forma de redactar un diagnóstico
r/c, m/p	«relacionado con», «manifestado por»	Enlaces del formato PES
SMART	Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, con Tiempo	Cómo se redacta un buen objetivo
SMS	Servicio Murciano de Salud	
Ley 41/2002	Ley básica (estatal) de Autonomía del Paciente	Información, consentimiento, historia clínica
Ley 3/2009	Ley de derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia	La versión murciana de la Ley 41/2002, más amplia
Ley 12/2014	Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia	Información pública y Gobierno Abierto
Ley 19/2013	Ley estatal de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno	La base estatal de la anterior
LOPDGDD	Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales	Límite de la transparencia

A1. Concepto, características y ventajas del Proceso de Atención de Enfermería (PAE)

- **Método sistemático** de trabajo que aplica el **método científico** al cuidado. Su uso es la **base del pensamiento crítico** de la enfermera. Objetivo: cuidado **individualizado, integral y eficiente**.
- **5 fases** interrelacionadas y cíclicas: **Valoración → Diagnóstico → Planificación → Ejecución → Evaluación** (la evaluación retroalimenta una nueva valoración).

Característica	Significado
Sistemático	Orden lógico, evita omisiones e improvisaciones
Intencionado / planificado	Deliberado, con un fin y un plan previo
Holístico	Dimensión biológica, psicológica, social y espiritual
Dinámico y cíclico	Las fases se solapan y retroalimentan
Interactivo	Paciente y familia participan (sobre todo en objetivos)
Documentable	Queda en los registros: comunicación, continuidad, evaluación de calidad

- **Ventajas**: más calidad y seguridad, lenguaje común (**NANDA-I** para diagnósticos, **NOC** para resultados y **NIC** para intervenciones), cuidado individualizado, carácter científico, continuidad de cuidados y datos para gestión e investigación.

- **Pensamiento crítico de Alfaro-LeFevre (modelo de los 4 círculos)**: características personales y conductas, conocimiento teórico y práctico, habilidades técnicas prácticas y habilidades interpersonales. («Habilidades interculturales» no es uno de ellos.)

A2. Valoración

- **Phaneuf**: proceso organizado y sistemático de búsqueda de información de diversas fuentes para conocer el grado de satisfacción de las necesidades, identificar problemas y recursos y planificar.
- Técnicas para recoger datos: **observación**, **entrevista** (comunicación) y **exploración física o medición**.
- Marcos de valoración: **14 necesidades de Henderson** y **11 patrones funcionales de Gordon**. NANDA-I recomienda los **patrones de Gordon** para la valoración inicial (y no los dominios de la taxonomía).
- **Validación de datos**: comprobar que están completos, que son exactos y consistentes, la congruencia entre datos subjetivos y objetivos, y distinguir el **dato observado de la inferencia**.
- Producto final: **perfil de salud** (problemas, riesgos, fortalezas, valores).

> **CLAVE PARA RECORDAR**
>
> - Patrones de Gordon (11, **relacionados entre sí**): **percepción-manejo de la salud** (hábitos, alergias, cumplimiento del tratamiento), nutricional-metabólico, eliminación, actividad-ejercicio, sueño-descanso, **cognitivo-perceptivo** (sentidos, dolor, lenguaje, memoria, toma de decisiones), **autopercepción-autoconcepto** (ánimo, imagen corporal, autoestima), rol-relaciones, sexualidad-reproducción, afrontamiento-tolerancia al estrés y valores-creencias. «Control del entorno» no es un patrón.

A3. Diagnóstico de enfermería

- **NANDA-I**: "juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad a un problema de salud real o potencial", que es la base de las intervenciones de las que la enfermera es responsable.
- Describe la **respuesta humana** de la persona (cómo vive el problema), **no la enfermedad**: eso es el diagnóstico médico.
- Proceso: interpretar y agrupar datos, compararlos con las características definitorias, formular el enunciado.

Formato PES (Marjory Gordon)

Elemento	Qué es	Enlace
P – Problema	Etiqueta diagnóstica NANDA-I	—
E – Etiología	Factor relacionado (causa abordable)	"relacionado con" (r/c)
S – Signos/síntomas	Características definitorias	"manifestado por" (m/p)

Tipo de diagnóstico	Formato	Ejemplo
Real (focalizado en el problema)	**PES**	Dolor agudo r/c incisión quirúrgica m/p EVA 8/10 (Escala Visual Analógica)
De riesgo	**PE** (sin síntomas)	Riesgo de infección r/c neutropenia
De promoción de la salud	**PS** (sin etiología)	Disposición para mejorar el autocontrol de la diabetes m/p deseo de aprender
Síndrome	**P** (+ factores propios)	Síndrome de desuso

- **Diagnóstico de riesgo** (definición NANDA-I): juicio clínico sobre la **vulnerabilidad** (susceptibilidad) de una persona, familia, grupo o comunidad para **desarrollar** una respuesta no deseada. Se usa cuando el paciente es propenso a un problema que aún no tiene.
- **NANDA-I 2024-2026**: **13 dominios, 47 clases y 277 diagnósticos**.
  - Dominios: 1 Promoción de la salud, 2 Nutrición, 3 Eliminación e intercambio, 4 **Actividad/reposo** (su clase 5 es el **autocuidado**: bañarse, vestirse…), 5 Percepción/cognición, 6 Autopercepción (incluye la imagen corporal), 7

Rol/relaciones, 8 Sexualidad, 9 Afrontamiento/tolerancia al estrés, 10 Principios vitales, 11 Seguridad/protección, 12 **Confort**, 13 Crecimiento/desarrollo.

- Novedades de esta edición: nueva clase en el Dominio 12 (Confort), revisión de los 8 ejes, términos MeSH (el vocabulario médico internacional de PubMed), lenguaje inclusivo, nuevos diagnósticos (alfabetización en salud, envejecimiento saludable) y retirada de diagnósticos simples (obesidad, insomnio).

- **Priorización**: gravedad/urgencia, jerarquía de **Maslow** (fisiológicas primero) o **ABC** en emergencias (vía aérea, respiración, circulación). El riesgo alto va antes que los de bienestar.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **El diagnóstico de riesgo NO lleva "S" y el de promoción de la salud NO lleva "E".**

! NANDA-I aconseja valorar con los **patrones de Gordon**, no con sus propios dominios.

A4. Planificación

Dos componentes: **objetivos** (resultados esperados) e **intervenciones**. El sujeto del objetivo es **el paciente**.

Criterio SMART	Significa
S – Específico	Un solo resultado concreto, centrado en el paciente
M – Medible	Términos observables o cuantificables
A – Alcanzable	Posible según su situación
R – Relevante / realista	Coherente con el diagnóstico y consensuado con el paciente
T – Tiempo	Plazo definido (corto: horas-días; largo: semanas-meses)

- **Berman**: los objetivos describen, en respuesta observable del paciente, lo que la enfermera espera conseguir. Sirven para dirigir intervenciones, evaluar y motivar.
- **Carpenito**: objetivos **del paciente** → diagnósticos de enfermería; objetivos **de la enfermera** → **problemas de colaboración**.
- **Alfaro-LeFevre** (dominios de los objetivos): **afectivos** (actitudes: "aceptará la dieta"), **cognitivos** (conocimientos: "enumerará los síntomas de hipoglucemia") y **psicomotores** (habilidades: "demostrará la técnica de inyección").
- **NOC** (resultados): **7 dominios** (salud funcional, que incluye crecimiento y desarrollo; salud fisiológica; salud psicosocial; conocimiento y conducta de salud; salud percibida; salud familiar y salud comunitaria), código de 4 dígitos (unos 540 resultados en la 6.ª edición; **612** en la 7.ª, de 2024). Cada resultado se mide con indicadores en escala **Likert de 5 puntos**: **1 = peor estado** (gravemente comprometido), **5 = mejor estado**.
- En la **planificación** se anotan la puntuación **basal** (cómo está ahora) y la **diana** (a dónde queremos llegar); después de intervenir se vuelve a puntuar y se compara. La diana se fija **antes** de intervenir, no después.
- **NIC** 8.ª ed. (2024): **614 intervenciones**, 60 nuevas y 11 eliminadas. Tiene **3 niveles**: **campos** (7; el manual los llama dominios), **clases** (30) e **intervenciones**. Campos: fisiológico básico, fisiológico complejo, **conductual** (p. ej., «Ayuda para hacer frente a situaciones difíciles»), seguridad, familia, sistema sanitario y comunidad.
- Cada intervención NIC tiene nombre (etiqueta), **definición** y una lista de actividades. Lo **normalizado** (lo que no se cambia) es la etiqueta y la definición; las actividades se eligen y adaptan a cada paciente.
- **Modelo AREA** (Análisis del Resultado del Estado Actual): estructura de razonamiento que **vincula** diagnósticos NANDA-I, resultados NOC e intervenciones NIC.
- El plan se **registra**: diagnóstico, objetivos con plazo, intervenciones (qué, cómo, cuándo, frecuencia, quién) y evaluación.

TRAMPAS DE EXAMEN

! En la escala Likert NOC el **5 es siempre el estado deseable**, también en indicadores negativos como el dolor (5 = ninguno).

A5. Ejecución y evaluación

Ejecución

- Puesta en práctica del plan: **preparación** (confirmar que la intervención sigue siendo necesaria y segura), **explicación** al paciente, **aplicación**, **valoración de la respuesta** durante la actividad y **registro**.
- **Delegación (Alfaro-LeFevre)**: traspasar a alguien competente la autoridad para hacer una tarea concreta **manteniendo la responsabilidad de los resultados**.
- Registro: lo antes posible, solo hechos (sin juicios de valor), preciso, conciso, terminología aceptada y firmado.

Evaluación

- Continua (formativa) durante todo el proceso y formal al final del plazo.
- Se compara el estado actual con los resultados esperados (**indicadores NOC + Likert**): objetivo **alcanzado, parcialmente alcanzado o no alcanzado**. Si no se logra, se analizan las causas.

Decisión	Cuándo
Continuar	Objetivo parcial, el plan sigue siendo adecuado pero necesita más tiempo
Modificar	No alcanzado por un plan inadecuado o cambios del paciente
Finalizar	Objetivo conseguido, causa resuelta; también por alta, traslado o fallecimiento

- **Diagnóstico de riesgo**: si la puntuación NOC se mantiene igual, las intervenciones están **controlando el riesgo**; el plan solo se cierra cuando desaparecen o se controlan los factores de riesgo.
- Si el paciente **empeora y no se identifican las causas**, el EIR da como correcto **continuar con el plan** (no se puede modificar sin saber qué falla) mientras se sigue valorando.

TRAMPAS DE EXAMEN

! La enfermera **nunca delega la responsabilidad final** de los resultados.

! El PAE no acaba al evaluar: es cíclico y reinicia con una nueva valoración.

BLOQUE B · Ley 3/2009 de derechos y deberes y Ley 12/2014 de Transparencia

B1. Ley 3/2009, de 11 de mayo: principios y asistencia sanitaria

- Es la Ley de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia. Su fin es **humanizar** la asistencia, tanto en la sanidad pública como en la privada.
- **Principios (Título I)**: universalidad, equidad, superación de desigualdades, integración y eficacia.
- **Humanización (art. 8)**: obligación legal de procurar el confort físico y psicológico del paciente.
- **Tarjeta Sanitaria Individual (TSI, art. 11)**: personal e intransferible; incorpora **Braille de forma sistemática**.
- **Libre elección** de facultativo y centro (art. 12) y **segunda opinión** (art. 14) en procesos complejos o graves.
- **Acceso y demora máxima (art. 13)**: si se supera el plazo, el paciente puede elegir **otro centro de la Región**, y lo paga el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Garantía de demora máxima (Decreto de 2006)	Plazo
Intervenciones quirúrgicas	**150 días**
Primeras consultas externas	**50 días**
Primeras pruebas diagnósticas	**30 días naturales**

Colectivos de especial protección

- **Embarazo, parto y puerperio (art. 15)**: parto natural con menos intervencionismo, analgesia epidural según indicación y demanda, lactancia materna y **acompañamiento ininterrumpido** por la persona que elija la mujer.
- **Menores (art. 16)**: acompañamiento de padres el máximo tiempo posible, continuidad educativa, evitar el ingreso si hay alternativas. Reforma por la **Ley 12/2018** (primeros 1.000 días): **contacto piel con piel inmediato e ininterrumpido** e identificación inmediata del recién nacido. Las rutinas (peso, profilaxis ocular, vitamina K) se **posponen**.
- **Mayores, discapacidad y enfermos psíquicos (art. 17)**: eliminación de barreras.
- **Crónicos y terminales (arts. 18-19)**: tratamiento del dolor, **sedación paliativa** si está indicada, acompañamiento, apoyo psicológico y rechazo de la obstinación terapéutica (no alargar la vida con tratamientos inútiles).
  - **Sedación paliativa**: dar fármacos, en las dosis y combinaciones mínimas necesarias, para **reducir la conciencia** de un paciente con enfermedad avanzada o terminal y aliviar **síntomas refractarios** (los que no ceden con otro tratamiento), **con su consentimiento**. No es eutanasia: no busca la muerte.
- **Extranjeros (art. 20)**: atención sin discriminación según la legislación estatal.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Plazos **150 – 50 – 30** (cirugía – consulta – prueba). Las pruebas son **días naturales**, no hábiles.

! Recién nacido sano y estable: lo prioritario es el **piel con piel**; llevarlo a la cuna térmica para pesarlo es el distractor.

! El Braille en la TSI es **sistemático**, no "a demanda".

B2. Intimidad, confidencialidad e información

Intimidad (arts. 21-23)	Confidencialidad (arts. 24-28)
Esfera física: cuerpo, pudor, espacio	Esfera **informacional**: datos, historia clínica
Biombos, puertas cerradas, cubrir zonas, tono de voz	Secreto profesional, contraseñas, acceso restringido
Presencia de estudiantes: informar antes; el paciente puede negarse	Datos genéticos: **gratuidad**, prohibido comerciar
Derecho a acompañante y a asistencia religiosa	Excepciones: salud pública (Enfermedades de Declaración Obligatoria, EDO), mandato judicial o fiscal, daño grave a tercero

Información asistencial (Título IV)

- **Titular**: el **paciente**. Se acaba el "pacto de silencio" (que la familia y los profesionales le oculten la verdad). La información debe ser veraz, continuada y **comprensible**, y le ayuda a decidir libremente.
- La familia o personas vinculadas solo se informan **si el paciente lo permite**, de forma expresa o tácita (Ley 41/2002).
- Si el paciente es incapaz, se informa a familiares o representantes, pero también a él en la medida en que comprenda.
- **Derecho a no saber**: lo ejerce el **paciente**; se registra y cede si hay riesgo para terceros.
- **Necesidad terapéutica (privilegio terapéutico)**: la ejerce el **médico** si informar causaría un daño grave; se justifica por escrito en la historia y se informa a los allegados.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Términos de **cuerpo y espacio** = intimidad; **datos y registros** = confidencialidad.

! La familia pide ocultar el diagnóstico a un paciente capaz: **no se acepta**; el titular es el paciente.

B3. Autonomía de decisión y consentimiento informado (Título V)

- **Libertad de decisión (art. 41)**, incluido el **derecho a rechazar** un tratamiento. El consentimiento informado protege el principio bioético de **autonomía**.
- **Regla general: consentimiento verbal**. Por **escrito (art. 42.2)**: intervención quirúrgica, procedimientos **invasivos**, investigación o experimentación, riesgos de notoria repercusión negativa y, en embarazadas, actuaciones con riesgo para el feto.
- **Revocable por escrito en cualquier momento**, sin justificar.
- **Sin consentimiento (art. 45)**: riesgo grave para la salud pública o urgencia vital sin posibilidad de autorización.

Consentimiento por sustitución (art. 46)

Supuestos: incapacidad legal, incapacidad de hecho (a criterio del médico, registrada) y menor sin madurez.

Orden de prelación	Quién decide
1.º	Representante designado en las **instrucciones previas**
2.º	Representante legal (tutor o curador)
3.º	Cónyuge o pareja de hecho
4.º	Parientes más próximos (a igual grado, el de mayor edad)

Edad	Consentimiento
< 12 años	Por representación (padres o tutores)
12-16 años	Se le escucha; si es **maduro** decide él; si no, los padres
≥ 16 años o emancipado	**Mayoría de edad sanitaria**: decide él. En una actuación de **grave riesgo** para su vida o salud, consiente el **representante legal**, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del menor (Ley 41/2002 tras la Ley 26/2015)

Instrucciones previas (arts. 50-51)

- **Qué son (art. 50)**: el documento en que una persona **mayor de edad, capaz y libre** deja escrito lo que quiere sobre sus cuidados y tratamientos para cuando no pueda expresarlo, y, tras su muerte, sobre el **destino de su cuerpo o sus órganos**. Puede nombrar un **representante** que hable con los profesionales. Los centros deben respetarlo y se incorpora a la historia clínica. Se puede cambiar o revocar en cualquier momento.
- Si un profesional objeta en conciencia o hay **dudas de interpretación**, se consulta al **Comité de Ética Asistencial** del centro (no al Servicio Jurídico).
- **Cómo se hacen (art. 51)**: por escrito ante **notario** (sin testigos), ante **personal de la Administración** (Registro o unidades del SMS) o ante **3 testigos** mayores de edad y capaces, de los que **al menos 2** no tengan parentesco hasta el **2.º grado** ni relación patrimonial.

TRAMPAS DE EXAMEN

! El consentimiento **no** es "siempre escrito": la regla es verbal.

! Ojo: el manual de este tema recoge la redacción antigua ("decide el menor y se informa a los padres"). La Ley 41/2002 vigente (reformada en 2015) dice que, en **grave riesgo**, consiente el **representante legal** tras oír al menor. Así lo recogen también los manuales de los temas 5 y 10.

! **Regla 3-2-2 de testigos. "Ninguno puede ser familiar" es falso: uno sí puede serlo.**

! En la sustitución, el familiar consanguíneo es el **último** escalón.

B4. Historia clínica y deberes (Títulos VI y VII)

- **Concepto (art. 52)**: conjunto de documentos de los procesos asistenciales. Finalidad principal: **asistencial**.
- **Requisitos (art. 53)**: legible, sin abreviaturas no reconocidas, **fechada y firmada**.
- **Conservación (art. 54.4)**: como mínimo **20 años desde el alta del último proceso** asistencial (la Ley 41/2002 estatal exige un mínimo de 5). Qué se destruye después (expurgo) lo valoran comisiones.

- **Acceso de profesionales (art. 55)**: solo para la asistencia del caso asignado. Curiosear historias es **falta muy grave** y puede ser delito. Para investigación o docencia, **datos anonimizados**.
- **Acceso del paciente (art. 56)**: tiene derecho a acceder y obtener copias, salvo los **datos de terceros** y las **anotaciones subjetivas** de los profesionales.
- **Fallecidos (art. 56.4)**: acceso de personas vinculadas por razones familiares o de hecho, salvo **prohibición expresa del fallecido**, datos de terceros o anotaciones subjetivas.
- **Deberes (arts. 61-63)**: respeto a profesionales (agredirlos es atentado contra la autoridad), facilitar sus datos de salud de forma leal y veraz, cuidar las instalaciones, uso racional de servicios y cumplir citas.
- **Alta forzosa (art. 64)**: si el paciente rechaza el tratamiento y **no firma el alta voluntaria**, la dirección del centro, a propuesta del facultativo, dispone el **alta forzosa**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Excepciones al acceso del paciente: **terceros** y **anotaciones subjetivas**.

! **Los 20 años cuentan desde el último alta, no desde la creación del documento ni el nacimiento.**

! Doble negativa (tratamiento y alta voluntaria) = **alta forzosa**, no retención ni juez.

B5. Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana

- Modelo de **Gobierno Abierto**. No confundir **información clínica** (privada, Ley 3/2009) con **información pública** (contratos, presupuestos, listas de espera agregadas, Ley 12/2014).
- **Objeto (art. 1)**: transparencia de la actividad pública, derecho de acceso, participación ciudadana y rendición de cuentas.

Concepto (art. 2)	Definición
Información pública	Contenidos y documentos en poder de la Administración, elaborados o adquiridos en sus funciones
Publicidad activa	La Administración **difunde por iniciativa propia** (retribuciones de altos cargos, listas de espera)
Derecho de acceso	El ciudadano **solicita** la información no publicada
Participación ciudadana	Intervenir en el diseño y evaluación de políticas
Gestión de documentos	Control sistemático de la creación a la conservación
Serie documental	Documentos de una **misma actividad administrativa**
Valoración	Fijar **plazos de conservación o eliminación**

- **Principios (art. 3)**: accesibilidad universal y **gratuidad** (consulta gratis; las copias o formatos especiales pueden tener tasas).
- **Portal de Transparencia** de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) y Consejo Regional de Participación Ciudadana.
- **Base legal**: el derecho de acceso a la información pública está en el **art. 105.b de la Constitución** (no es un derecho fundamental) y en la **Ley 19/2013** estatal, que lo reconoce a **todas las personas** (art. 12), sin exigir nacionalidad ni residencia.
- **Límites**: la protección de datos personales (LOPDGDD). Se concede **acceso parcial** anonimizando los datos de salud.
- Plazo de resolución: **20 días hábiles**, prorrogables otros 20. Sin respuesta: **silencio negativo**.
- No hace falta **motivar** la solicitud. Órgano garante: **Comisionado de la Transparencia** (unipersonal, 4 años), que sustituye al antiguo Consejo de la Transparencia.

TRAMPAS DE EXAMEN

! La Administración publica sin que nadie lo pida = **publicidad activa**, no derecho de acceso.

! Silencio en una solicitud de acceso = **negativo** (desestimatorio).

! Transparencia: **20 días hábiles**. Demora de pruebas (Ley 3/2009): **30 días naturales**.

! Fechas: Ley 3/2009, de **11 de mayo**; Ley 12/2014, de **16 de diciembre**.

Otras preguntas del test de este tema

Estas preguntas del EIR caen en el test de este tema aunque su materia es de otros apartados del programa. Aquí tienes lo necesario para responderlas.

- **Final de la vida**: los cuidados se adecuan a **aliviar el sufrimiento** y lograr el máximo **confort**, respetando los deseos del paciente (máxima expresión del principio de **autonomía**). El paciente puede **rechazar la información** y también rechazar o retirar un tratamiento aunque el médico no esté de acuerdo; sus instrucciones previas se respetan.
- **Entrevista familiar para la donación (Organización Nacional de Trasplantes)**: se **informa** a la familia de cómo se hará la extracción y de la **restauración del cadáver** (no se oculta); el consentimiento incluye extraer injertos vasculares; si el posible donante en asistolia controlada está consciente y es competente, consiente **él mismo**; ante una negativa, se valora si es definitiva.
- **Ley 14/2007 de Investigación Biomédica**: la salud del participante está por encima del interés de la ciencia (no se le retrasan ni niegan tratamientos); tiene derecho a **conocer sus datos genéticos**; cederlos a terceros exige su **consentimiento expreso y por escrito**; en menores o incapaces se admite el consentimiento por representación.
- **NIC «Facilitar el duelo» (5290)**: usar palabras claras como «muerte» o «muerto», **sin eufemismos**; responder a las preguntas de los niños y animar a hablar de la pérdida.

Etiqueta NANDA-I	Lo que preguntan
Ansiedad excesiva (00400, nueva en 2024-2026)	Preocupación desproporcionada y persistente. Una característica definitoria es la **dilatación pupilar**
Patrón respiratorio ineficaz	La inspiración o espiración no ventila bien: **disnea, uso de músculos accesorios, aleteo nasal** (p. ej., fracturas costales con dolor)
Control de impulsos ineficaz	Reacciones **rápidas y no planeadas**, sin pensar en las consecuencias
Trastorno de la identidad personal	Incapacidad para mantener una percepción **completa e integrada del «yo»**
Duelo inadaptado	Diagnóstico **nuevo** en NANDA-I 2021-2023
Riesgo de nivel de glucemia inestable (00179)	Actividades: enseñar los signos de hipoglucemia, autocontrol de la glucemia, diario de comidas. «Conducta de mantenimiento del peso» es un resultado NOC, **no** una actividad